

✓ 추나실습 써머리 가이드

- 중간(30%, 과제)+기말(30%)+출석(20%)+발표(10%, 기말 구두 시험)+실습태도(10%)
- 검은색: ppt 내용 / **붉고 빨간색 글씨: 강조** / 초록색: 교수님 설명
- (실습 중 첨언): 수업시간에 교수님에게 저희 조가 피드백 받은 내용입니다. 다른 피드백 받은 내용이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

5장 체간부 추나치료

상부 흉추 근막추나기법

좌위 하부 흉추 중립성 기능부전 근육이완/강화기법

1) 적응증: 중립위, 회전대측측굴변위, 중립성 기능부전

2) 치료

- 환자의 자세: 환자는 측만이 있는 반대쪽 손으로 측만측 어깨를 감싸는 좌위를 취한다.
- 의사의 자세: 환자의 측만의 반대쪽 뒤에 선다.
- 주동수: 측만이 있는 쪽 손으로 엄지손가락을 **측만된 추골의 정점에 접촉한다.**
- 보조수: 측만의 반대쪽 손으로 환자의 **측만 반대측 액와를 통과시켜 환자의 손목을 잡는다.**
→ 반대로 측굴을 만들어준다고 생각하기
- 교정의 방향: 변위의 반대방향으로 힘을 준다.

3) 치료절차

- 측만의 정점에서 측만측에서 반대측으로의 병진운동을 시켜서 대측회전과 환측 측굴(아래의 좌측굴 우회전의 중립성 기능부전인 경우 우측굴 좌회전을 유도하는 것임)을 유도하여 새로운 제한 장벽에 놓는다.
- 의사는 환자가 측만 반대측으로 측굴하는 등척성 수축에 대해 3-5초간 저항한다(아래의 좌측굴 우회전의 중립성 기능부전인 경우 환자에 의한 좌측 측굴 등척성 수축에 대해 의사가 저항하는 힘을 준다).
- 이완 후 새로운 제한 장벽을 찾아서, 이를 3-5회 반복한다.

4) 좌측굴, 우회전 중립성 기능부전



- 좌측굴 우회전된 상태 = 우측굴 좌회전을 만들기 (Type 1)
- 측만의 치료보다는 기능부전을 풀어주는 것
- 어깨뼈 하각(T7)~늑골각(T12) 사이에서 튀어 나온 부분을 찾고 주동수로 밀면서 시행
→ 주동수로 힘을 주기보단 액와를 통해 보조수를 들어서 측굴을 시키고 회전을 줌
(주동수로 미는 힘보다 측굴 회전이 주용)
→ 이때 환자를 베드 끝으로 이동시킨 뒤, 환자 어깨를 손으로 잡으라고 말함

(1학기 내용)

- 좌측굴, 우회전 변위가 있기 때문에 우측굴, 좌회전을 시킴
- 방법: 왼쪽 어깨가 돌리기 때문에 우측굴이 되고, 그 상태에서 몸을 돌려 좌회전을 만들
→ 마찬가지로 원하는 분절을 손으로 잡고 그 지점을 변곡점으로 만든 상태에서 동작을 시행
- 추가(중요 X): 뒤로 기울어지지 않은 채, 측굴 회전이 반대로 일어나면 몸의 전체적인 축은 유지된 상태

요추 신연기법

복와위 요천관절 신연기법

1) 적응증

- 요부근의 일반적인 긴장, 척추후관절 증후군, 요추 과전만
→ 허리가 아픈 환자 혹은 복잡추나 전 근육 푸는 용도 (간단, 무리가 안감)

2) 치료

- 환자의 자세: 복와위
- 의사의 자세: 환자의 요부 측면에 빗장 자세로 선다.
- 주동수: 양손의 장근부로 두방수의 경우 **흉추부의 극돌기**에, **족방수의 경우 요추부의 극돌기** 및 **천골부에 접촉한다.**
- 보조수: 주동수와 동일
- 교정의 방향: **후방에서 전방으로**, 두방수는 **족방에서 두방으로** 족방수는 **두방에서 족방으로** 힘을 가한다.

3) 치료절차

- 의사는 양손의 장근부로 환자의 극돌기를 잡고 흉추부 접촉수는 족방에서 두방으로, 요추부 및 천골부 접촉수는 두방에서 족방으로 신전한다.
- 추나치료테이블의 낙차를 이용해도 좋으며 가볍게 순간교정해도 좋다.

4) 복와위 요천관절 신연기법



- 척추 사이 공간을 늘려준다는 느낌으로 L4 → L1, T12 이런식으로 올라가면서 시행(L5의 극돌기는 측지가 어려움)
(첨언 1) 호흡을 크게 들이쉬고, 내쉴 때 밀면 더 신전됨
(첨언 2) 그냥 위아래로 환자 몸에 평행하게 밀면 살만 밀려서 통증을 느끼기 때문에 약간 아래로(45°)정도로 민다고 생각하기. 이때 왼손, 오른손 어느 손이 위아래 가든 상관 없음(편한 손으로 시행)

측와위 요추 신연기법

1) 적응증: 요부근의 일반적인 긴장, 척추후관절 증후군, 요추의 회전변위

2) 금기증: 급성요부염좌는 천천히 시행하거나 주의, 압박골절환자 → **회전이 들어가기 때문**

3) 치료

- 환자의 자세: 측와위
 - 회전변위가 일어난 쪽을 위로 향하여 측와위 자세
 - 환자의 아래쪽 어깨는 전방으로 위쪽 어깨는 후방, 환자의 팔은 서로 깎지 낀 상태로 체간의 측면에 위치
 - 환자의 아래쪽 다리는 적당한 굴곡을 주어 위치시키고 위쪽 다리는 구부려 발목을 아래 다리의 오금에 건다.
- 의사의 자세: 환자의 정면 방향에 펜싱 자세로 선다. 족방슬부 및 대퇴부는 환자의 위쪽 다리의 슬부나 대퇴부에 접촉한다.
- 주동수: 족방수. 족방수의 손가락으로 환자의 구부린 발의 오금에 두고 엄지는 무릎측면에 접촉한다.
- 보조수: 두방수. 두방수의 손바닥으로 윗어깨의 전면에 접촉한다.
- 교정의 방향: 족방수로는 환자의 후방에서 전방으로, 두방에서 족방으로 당기고, 두방수는 환자의 전방에서 후방으로 약간 족방에서 두방으로 어깨를 민다.

4) 치료절차

- 의사는 두방수와 족방수를 서로 교차하듯 신연한다. 두방수는 두방으로 밀면서 상부 체간을 고정시키고 족방수로는 바닥 쪽으로 눌러서 이완을 제거한 다음 주동수를 이용하여 가볍게 환자의 허리를 요동하듯 힘을 주었다 뺀다는 동작을 반복하여 환자의 요부를 신연시킨다.
- 이때 시술자의 족방 하지를 동시에 이용하여 리드미컬하게 시행하는 것이 좋다.

5) 측와위 요추 요동 신연기법



- 흔히 말하는 Lumbar roll 자세와 비슷함.
- 어깨를 등 뒤로만 밀면 등이 밀리는 느낌이 들면서 통증이 강함. 어깨를 머리쪽과 뒤의 중간 정도로 밀어서(45°나 좀 더 머리쪽으로 밀기) 옆으로 늘어나게 하기 (신장시킨다는 점에 의의)
(첨언) 환자가 옆으로 누웠을 때 허리가 너무 굽어있으면 안됨. 아랫발 오금에 뒷발 발목을 걸고, 바닥쪽 어깨를 살살 빼준 뒤 깍지를 끼게 한 뒤 시행. 다리를 고정하고 어깨를 밀어줄 수 있고, 어깨를 고정하고 다리를 밀 수 있음

요추 교정기법

측와위 요추 중립성기능부전 교정기법

1) 적응증: 중립성 기능부전, 요추의 회전 대측측굴변위, 요추의 측만

2) 금기증: 급성요부염좌, 압박골절, 척추종양

3) 치료

- 환자의 자세: 측와위, 추체의 회전된 쪽이 아래로 가게 눕는다.
- 의사의 자세: 환자의 정면방향에 펜싱자세로 선다.
- 주동수: 족방수의 전완부로 장골에 접촉한다.
- 보조수: 두방수의 전완부로 액와부에 접촉한다.
- 교정의 방향: 보조수로 환자 체간을 후방으로 회전하고, 주동수로 장골을 전방으로 당긴다.

4) 치료절차

- 중립성 기능부전과 반대 방향의 체간의 회전과 측굴을 유도하기 위해 환자의 아래쪽 팔꿈치를 전방으로 잡아당겨 위쪽 어깨를 후방으로 위치
- 환자의 팔은 서로 깎지 낀 상태로 체간의 측면에 위치시킨다.
- 환자의 위쪽 다리는 구부려 발목을 아래 다리의 오금에 건다.
- 이 상태에서 위 교정방향에 따라 의사의 체중을 이용하여 순간교정한다.

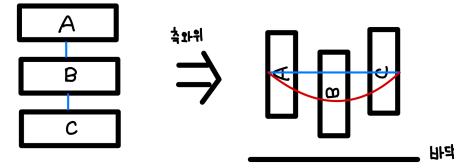
5) 측와위 요추 중립성기능부전 교정기법



- 위에는 신장기법이라면, 이번에는 교정기법. 중립성 기능부전이기 때문에 굴곡, 신전이 없는 상태에서 움직임을 만들
(첨언 1) 척추가 굽거나 펴지지 않도록 중립상태를 만들고, 아래 팔을 당겨서 회전을 만드는데, 이때도 몸이 구부러지거나 펴지지 않아야 한다. 이후 아래 팔을 당겨 회전을 만들고, 이를 유지한 상태에서 손을 깎지끼고 옆구리에 뒀다.
(첨언 2) 손은 극돌기에 접촉하고 두방수로 액와부를 밀어 회전을 유지하고 족방수로 골반을 당기면서 제한장벽까지 간 다음, 제한장벽에서 체중을 이용하여 누른다. (상체와 하체가 각각 반대로 회전하면서 원하는 요추에서 서로 회전이 맞물려 변곡점이 되게 하기)

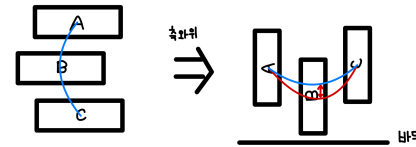
▷ 추가설명

1) 개념



- 정렬이 정상인 척추가 측와위로 눕게 되면 중력에 의해 추체가 측굴하게 된다.

2) 기법



- 옆의 기법에서 추체의 회전된 쪽이 아래로 가게 눕는다고 하였는데, Type 1 중립성기능부전이기 때문에, 추체의 측굴된 쪽은 위로 가게 된다.
- 이 상태에서 측와위를 하면 측굴 변위가 있는 곳에서 측굴이 더 심하게 된다.
- 이러한 측굴 상태를 완화하기 위해서 바닥쪽 팔을 의사쪽으로 당겨서 회전을 만들어주는 것이다.
- 예시: 우측굴 좌회전 변위가 있는 환자에게, 왼쪽이 아래로 가게 누우면 우측굴이 더 심해진다. 이때 아래 팔을 살살 당기면서 우회전을 만들어주면 Type 1 상태이기 때문에 좌측굴의 움직임이 생기면서 측굴이 완화되고, 이상태로 어느정도 중립위 위치를 만들어줘야 한다.

요추 교정기법

좌위 요추 양측성 굴곡변위 근육이완/강화기법

1) 적응증: 요추부 신전 제한, 요추부의 양측성 굴곡 변위

2) 금기증: 어깨관절 이상

3) 치료

- 환자의 자세: 좌위, 환자는 좌위 상태에서 추나테이블에 양다리를 벌리고 앉아 무릎으로 테이블을 꼭 낀다. 등, 목, 머리를 편다. 좌우로 양손을 반대쪽 어깨를 감싸 쥔다.
- 의사의 자세: 환자의 뒤에 선다.
- 주동수: 내방수의 장근부를 환측 하부요추 극돌기에 접촉하여 전하방으로 근육이완/강화기법으로 치료한다.
- 보조수: 외방수로 환자의 교차된 팔꿈치를 잡아서 상체를 고정한다
- 교정의 방향: 주동수는 환자의 후방에서 전방으로 힘을 가하고, 보조수는 환자의 족방에서 두방으로 당긴다.

4) 치료절차

- 의사는 환자의 뒤에 서서, 주동수의 장근부를 환측 하부요추 극돌기에 접촉하고, 보조수는 환자의 교차된 팔꿈치를 잡아서 상체를 고정한다.
- 주동수는 환자의 후방에서 전방으로 병진운동을 하면서 체간의 신전 장벽을 찾는다.
- 보조수는 환자의 체간을 굴곡시키는 힘주기에 대해 족방에서 두방으로 당겨 등척성 수축을 실시
- 새로운 신전제한 장벽을 찾고 이와 같은 것을 3-5회 반복한다.

5) 좌위 요추 양극성 굴곡 근육이완/강화기법



- 사진은 손이 좀 높게 갔는데, 요추에 손이 닿고, 지난주 신전 변위와 반대로 굴곡변위가 발생하면 윗 분절은 간격이 좁고, 아랫분절은 간격이 넓어지게 된다. 이때 변위가 있는 척추의 아랫분절을 손으로 받쳐 기법을 시행
→ 예시: L1에 문제가 있으면 L2에 손을 댄다.
- 팔꿈치를 잡은 손이 환자를 들어올리는 것이 아닌, 의사의 몸쪽으로 당기는 것으로 뒤에서는 앞으로 밀고, 앞에서는 뒤로 당기면서 반대 힘을 주게 되고, 굴곡된 척추가 서로 밀리면서 장력이 반대로 발생하여 굴곡 변위를 조금 줄여주는 것
- MET 시행할 때 시술자는 신전하는 힘, 환자는 숙이는 힘을 줌